# ANESTESIA PRÁCTICA II

DR. GUSTAVO RAMBOA

## PROPOFOL Y KETAMINA

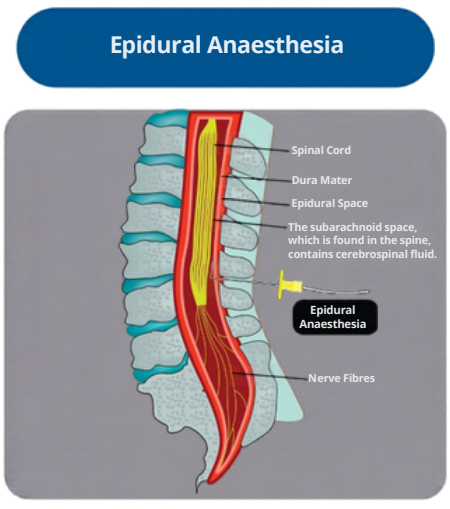
- Propofol: emulsión lipídica, inicio 90seg, antiemético; dosis 1-2mg/kg. Disminuye FSC y CMRO2; causa hipotensión, depresión miocárdica, dolor a la inyección.
- Ketamina: antagonista NMDA, 1-3mg/kg IV/IM; analgesia disociativa. Aumenta PA, FC, FSC y PIC (contraindicada en TCE). Combinar con atropina (sialorrea) y midazolam (alucinaciones).

## ETOMIDATO Y TIOPENTAL

- Etomidato: alta estabilidad hemodinámica, no libera histamina; inductor de elección en shock o inestabilidad hemodinámica.
- Tiopental: barbitúrico ultracorto, reduce PIC y CMRO2 hasta 50% (protección cerebral); hipotensión, libera histamina, contraindicado en porfiria.

## ANESTESIA RAQUÍDEA (SUBARACNOIDEA)

- Punción por debajo de L2 (L3-L4 o L4-L5) para evitar lesión del cono medular. Agujas punta de lápiz (Whitacre/Sprotte) redujeron la cefalea pospunción de 20% a <1%.
- Inicio rápido (3min), volúmenes bajos (1-3mL); bloqueo simpático causa hipotensión en 70% de los casos.




## OPIOIDES Y SU ANTAGONISMO

- Fentanilo: 75-125 veces más potente que morfina. Remifentanilo: metabolismo por esterasas plasmáticas, vida media ultracorta.
- Complicaciones: bradicardia, depresión respiratoria, tórax leñoso (rigidez torácica); suspensión brusca de remifentanilo causa hiperalgesia.
- Naloxona: antagonista (30-45min); su inyección rápida puede desatar descarga simpática con arritmias y edema pulmonar neurogénico.

## RELAJANTES MUSCULARES Y REVERSIÓN

- Despolarizantes: succinilcolina, degradada por colinesterasa plasmática, duración 5-6min.
- No despolarizantes: rocuronio, atracurio.
- Reversión: neostigmina + atropina (mitiga efectos muscarínicos); rocuronio tiene reversión específica con sugammadex.

## ANESTESIA EPIDURAL Y SUSPENSIÓN DE ANTICOAGULANTES

- Localización: pérdida de resistencia o gota pendiente de Gutiérrez; catéter continuo 48h. Volúmenes mayores (20-25mL), latencia 15-20min. Dosis de prueba: 3mL con adrenalina 1:200,000.
- Suspensión previa: aspirina (mantener sola), clopidogrel 7-10 días, HBPM 12-24h, warfarina 3-5 días (confirmar INR).

